

國立臺灣大學醫學院附設醫院 臨床醫事人員培訓計畫

二年期呼吸治療師訓練計畫

96.09.10 初訂
105.10.06 修訂第十版
106.03.23 修訂第十一版
108.04.23 修訂第十二版
110.03.26 修訂第十三版
111.04.14 修訂第十四版
112.03.15 修訂第十五版
113.03.12 修訂第十六版
114.03.28 修訂第十七版

壹、基本資料

負責人	陳惠娟	職稱	呼吸治療師
聯絡人	陳惠娟	職稱	呼吸治療師
聯絡電話	0936-946-818	現職單位	呼吸診療科
E-mail	jiuan214@ntuh.gov.tw		

貳、訓練目的

經由「臨床醫事人員培訓計畫」，培養及增強新進呼吸治療師基本呼吸照護能力，提升呼吸治療照護品質。

- 一、養成新進呼吸治療師應用「基本呼吸治療專業知識」、執行「實證科學」及「臨床專業」能力導向的呼吸治療專業處置。
- 二、養成新進呼吸治療師建立以「病人為中心」和「全人醫療照護」的臨床工作態度及技能。
- 三、養成新進呼吸治療師能遵循法規，並具備執業所需的專業倫理以及溝通協調能力。
- 四、培養新進呼吸治療師參與跨領域團隊相互合作、共同照護的能力。
- 五、執行能力導向呼吸治療訓練。

參、訓練師資

一、課程負責人：

為具教學醫院臨床教學經驗五年以上呼吸治療執業經驗之專任呼吸治療師，取得教師認證資格，有適當訓練學理與臨床經驗兼備，負責新進呼吸治療師相關事務，具備統籌訓練計畫之規劃、執行及成效評估之能力。

二、課程師資：

課程師資須符合衛生福利部最新公告之「臨床醫事人員培訓計畫申請作業要點」之規定，初次擔任教師者需兩年 10 小時「提升教師教學技能」課程(或活動)；認證效

期至多三年，申請認證展延者，每年至少 4 小時。並且具有臨床教學經驗或實務經驗之專任呼吸治療師；鼓勵教師參與全人醫療照護教育師資培育課程並取得院方全人醫療照護教育師資證書，並定期認證、展延。

- 三、擔任呼吸治療臨床指導教師須服務教學醫院滿三年以上，並取得醫策會教師認證。擔任呼吸治療專責指導教師須服務教學醫院滿五年以上，並取得醫策會教師認證和呼吸診療科專責指導教師證書。師生比不得低於 1:3（即每 1 位教師於同一時期至多指導 3 名受訓人員）。

肆、訓練課程

一、基礎課程階段

(一) 基礎專業技能

達成目標	1、具備維護病人安全之知識及能力。 2、能運用基礎臨床專業的能力 3、熟悉組織工作規則。
訓練內容	1. 第一週前三天 新進人員到職訓練： a.醫院簡介及認識醫院環境。 b.認識呼吸治療組織及規章。 c.瞭解工作常規及資訊系統操作。 d.病人安全：病人轉換單位之流程、病人辨識(病人外送檢查)與交班。 e.成人呼吸器模擬訓練：基本設定及組裝管路。 f.完成線上數位影音課程學習 TMS「總院-跨領域團隊合作照護訓練基本核心課程」。 2. 第二~九週 a.熟悉各式單張之填寫(含呼吸照護紀錄電子表單、使用呼吸器病人紀錄表、呼吸器保養卡、呼吸照護登錄系統VPN表單)，TMS課程編號 144077「呼吸診療科病歷書寫」。 b.基本專業課程與技能 (共 12 小時) ● 氧療、Airvo2(互動式教材)以及溼氣與噴霧治療之互動式教材練習和臨床實務操作(1 小時)。 ● 基本專業技能與呼吸治療儀器操作練習與臨床應用(含weaning Parameter、indirect calorimetry、Cuff Leak Test、Cst / Raw / Auto-PEEP等)(2 小時)。 ● 呼吸治療資訊系統介紹(呼吸照護登入系統VPN)(1 小時)。 ● 胸腔復原治療pulmonary rehabilitation (TMS呼吸治療課程 86502)(2 小時)。 ● 特殊呼吸治療技術(iNO、HFOV) OSCE模擬訓練，包含組裝管路及基本設定(2 小時)。 ● 特殊呼吸治療技術(Prone position、Recruitment management)之臨床應用(2 小時)。

	● 建立臨床感染控制觀念，包含手部衛生與隔離衣穿脫程序(2 小時)。 c.應用可信賴專業活動 (EPAs)之項目： <table><tr><td>(EPA-1)提供病人藥物吸入治療照護</td></tr><tr><td>(EPA-5)提供病人氧氣治療照護</td></tr><tr><td>(EPA-6)使用侵襲性呼吸器病人之初始設定及照護</td></tr></table> d.呼吸治療問題之處置與緊急事件處理。 e.熟悉標準作業流程程序書。 f.瞭解呼吸治療師夜班及假日班工作常規，並跟值小夜、大夜及假日班至少各一至二次(依學員能力調整)。 g.參與跨領域團隊合作照護討論會。 h.在有資深呼吸治療師引導下，共同執行呼吸治療照護業務。 3. 第十~十二週 兒童照護訓練(包含以下小兒訓練課程合計至少 8 小時)： a.熟悉兒科侵襲性與非侵襲性呼吸器管路安裝及設定： ● 兒科呼吸器之臨床操作(含Avea、SLE 5000、SLE 6000、VN500、Bipap、under water CPAP、HFNC等)(2 小時)。 b.瞭解RDS與呼吸治療相關處置(TMS呼吸治療課程 130967)(1 小時)。 c.新生兒呼吸生理(TMS呼吸治療課程 86499)(1 小時)。 d.臨床常見兒科疾病與處置(TMS呼吸治療課程 119520、86501)(2 小時)。 e.使用單位呼吸器進行呼吸治療技術(iNO、HFOV)之小兒管路組裝及基本設定模擬訓練模擬訓練(2 小時)。	(EPA-1)提供病人藥物吸入治療照護	(EPA-5)提供病人氧氣治療照護	(EPA-6)使用侵襲性呼吸器病人之初始設定及照護
(EPA-1)提供病人藥物吸入治療照護				
(EPA-5)提供病人氧氣治療照護				
(EPA-6)使用侵襲性呼吸器病人之初始設定及照護				
訓練時間	3 個月			
訓練方式	a.依呼吸診療科呼吸治療師訓練計畫執行。 b.由臨床指導老師 1 對 1，以個案討論、線上數位影音課程學習以及臨床回覆示教學習。 c.臨床實作學習：依學員能力及臨床狀況由臨床指導老師彈性調整。 ● 第一個月與臨床指導老師共同照顧 4-6 人。 ● 第二個月與臨床指導老師共同照顧 6-8 人。 ● 第三個月與臨床指導老師共同照顧 8-10 人。 d.多元化教材：TMS影音教學課程呼吸治療專業課程必修至少 5 小時、LINE聊天機器人、AIRVO互動式教材、Kahoot互動式教材。 e.於臨床技能中心進行教案情境模擬訓練。 f.使用單位教具進行OSCE模擬訓練。 g.臨床指導老師及主管進行輔導訪談關懷座談會。 h.自學：參閱標準作業程序書、工作規範、大醫雲RT電子書、TMS線上影音教學課程、教科書、PubMed、臨床指南、UpToDate等等。 i.參與學會、公會及醫策會開設之相關訓練課程。			
評核標準 (方法)	a.成人呼吸器模擬訓練管路裝置與初始設定評分。 b.學前筆試測驗，通過成績達 80 分以上，未達 80 分需安排授課。 c.專業課程：專責教師進行授課與學前及學後筆試測驗，學後需通過筆試成績達 80 分以上。			

d.專業技術：依呼吸診療科標準作業流程程序書，執行前測專業技術測驗 達 80 分以上即不用後測，如需後測驗成績應達 80 分以上。	
e. EPA可信賴專業活動信賴等級評估：	
評核項目：	評核頻率：
(EPA-1)提供病人藥物吸入治療照護	每兩個月至少一次
(EPA-5)提供病人氧氣治療照護	每兩個月至少一次
(EPA-6)使用侵襲性呼吸器病人之初始設定及照護	每兩個月至少一次
進行評核方式：臨床任務評核、OSCE教案評核、個案討論、mini-CEX、DOPS、筆試等綜合性評估。	
完訓認定：信賴等級達「Level 4 可獨立執行」	
備註：信賴等級劃分如下：	
信賴等級	內容
Level 1	學習者在旁觀察
Level 2a	教師在旁逐步共同操作。
Level 2b	教師在旁必要時協助。
Level 3a	教師事後逐項確認。
Level 3b	教師事後重點確認。
Level 3c	必要時知會教師確認。
Level 4	可獨立執行。
f.每 3 個月運用mini-CEX直接觀察臨床知識、技能和態度等專業能力，並予以回饋。	
g.臨床指導老師每個月一次輔導訪談，將新進人員學習情形報告組長與教學主任，必要時得以延長臨床指導時間。	
h.受訓學員對臨床教師滿意度調查：	
●每個月教學部線上問卷調查。	
●每三個月呼吸診療科新進人員對教師評核。	
●呼吸治療暨跨領域相關課程問卷調查。	
i.受訓學員考核表：	
●每三個月一次床邊查房病例導向討論 Case-Base-Discussion，進行 360 度評核與具體個案實證臨床應用探討。	
●每三個月學員核心能力SIRIPPP自評及教師核心能力評核。	
※學習成效不佳之輔導機制：	
當學習成效未達標準時，由教學計畫負責人啟動輔導機制。	

g.臨床指導老師每個月一次輔導訪談，將新進人員學習情形報告組長與教學主任，必要時得以延長臨床指導時間。

h.受訓學員對臨床教師滿意度調查：

- 每個月教學部線上問卷調查。
- 每三個月呼吸診療科新進人員對教師評核。
- 呼吸治療暨跨領域相關課程問卷調查。

i.受訓學員考核表：

- 每三個月一次床邊查房病例導向討論 Case-Base-Discussion，進行 360 度評核與具體個案實證臨床應用探討。
- 每三個月學員核心能力SIRIPPP自評及教師核心能力評核。

※學習成效不佳之輔導機制：

當學習成效未達標準時，由教學計畫負責人啟動輔導機制。

(二) 人文素養與全人照護教育課程

達成目標	1、能遵循法規、感染管制及專業倫理規範，以維護病人安全與權益。 2、能以全人照護的觀念執行臨床照護。
訓練內容	人文素養課程(8 小時) 1、建立醫療韌性與病人安全文化 (2 小時)。

	2、高齡衰弱全人跨領域照護(2 小時)。 3、感染管制相關課程(含新興傳染病之認識)(2 小時)。 4、行政管理相關課程(1 小時)。 5、心理健康相關課程 (含心理韌性/復原力〔Resilience〕) (1 小時)。 全人醫療照護課程(12 小時) 1、心理、靈性及社會(2 小時)。 2、健康促進及疾病預防(2 小時)。 3、安寧療護及長期照護(2 小時)。 4、病人安全與醫療倫理(3 小時)。 5、高齡化照護的相關議題(3 小時)。
訓練時間	第一年至少 12 小時，第二年至少 6 小時。
訓練方式	a.TMS 影音教學課程線上學習。 b.可參與教學醫院或專業團體如學公會、醫策會開設之相關訓練課程。 c.本院或其他教學醫院人文素養課程。
評核標準 (方法)	a.網路線上學習後測驗通過及格分數。 b.課程之出席或時數證明。 c.實務演練。

二、核心課程階段

進階專業技能

達成目標	1、能獨立執行基礎照護能力。 2、運用專業核心能力，提升臨床病人的照護效能及品質。 3、根據職場長期觀察評估之任務信賴等級達「Level 4 可獨立執行」。		
訓練內容	進階專業技能(共 20 小時)： a.參與基本生命復甦術(BLS)訓練課程或高級心臟救命術(ACLS)訓練並取得合格證書(5 小時)。 b.熟悉居家健保相關事宜(1 小時)。 c.常見呼吸治療相關治療處置與呼吸治療能力： ●病人氧氣使用與諮詢(1 小時)。 ●病人使用呼吸器初始設定及照護(1 小時)。 ●病人使用呼吸器的緊急處置(2 小時)。 ●病人侵襲性呼吸器的脫離處置(2 小時)。 ●呼吸窘迫病人之處置(2 小時)。 ●病人藥物吸入處置或諮詢(1 小時)。 ●氣道處置(1 小時)。 ●臨床小兒氣道照護(2 小時)。 ●臨床小兒呼吸生理學(2 小時)。 d. 應用可信賴專業活動 (EPAs)之項目： <table><tr><td>(EPA-3) 提供胸腹手術病人肺擴張治療照護</td></tr><tr><td>(EPA-8) 使用呼吸器病人之緊急處置</td></tr></table>	(EPA-3) 提供胸腹手術病人肺擴張治療照護	(EPA-8) 使用呼吸器病人之緊急處置
(EPA-3) 提供胸腹手術病人肺擴張治療照護			
(EPA-8) 使用呼吸器病人之緊急處置			

	(EPA-9) 使用呼吸器病人之轉送照護	
	(EPA-10) 使用侵襲性呼吸器病人之脫離照護	
	(EPA-11) 移除病人氣管內管之照護	
	e.跨領域團隊共同照護訓練。 f.呼吸治療技能之原理及操作。 g.熟悉各種類呼吸器特性及原理。 h.熟悉並能執行外送檢查之操作。 i.熟悉呼吸治療師夜班及假日班工作常規，並獨立值小夜、大夜及假日班。 j.視學員學習狀況進行情境模擬教學(使用單位呼吸治療器具與模擬教案)。 k.具備實證醫學與臨床應用能力。	
訓練時間	9 個月	
訓練方式	a.依呼吸診療科呼吸治療師訓練計畫執行。 b.臨床實作學習。 c.獨立照顧專責單位，照顧病人 10-12 人並依學員能力及臨床狀況由臨床指導老師彈性調整。 d.多元化教材：TMS呼吸治療專業課程必修至少 10 小時、LINE聊天機器人、SDM (氣管切開術、選擇居家與呼吸照護病房)、Kahoot互動式教材。 e.自學：參閱標準作業程序書、工作規範、大醫雲RT電子書、TMS線上影音教學課程、教科書、PubMed、臨床指南、UpToDate。 f.儀器操作及各項技術回覆示教。 g.於臨床技能中心進行教案情境模擬訓練。 h.使用單位教具進行模擬訓練。 i.參與呼吸診療科各組活動。 j.臨床指導老師及主管進行訪談輔導關懷座談會。 k.參與學會、公會及相關專科學會繼續教育課程。	
評核標準 (方法)	a.專業課程：依照呼吸治療師訓練計劃專業課程，由專責教師進行授課與學前及學後筆試測驗，學後需通過筆試成績達 80 分以上。 b.專業技術：依呼吸診療科標準作業流程程序書，執行前測專業技術測驗達 80 分以上即不用後測，如需後測驗成績應達 80 分以上。 c.每 3 個月運用mini-CEX直接觀察臨床知識、技能和態度等專業能力，並予以回饋。 d.個案報告一篇，通過成績 80 分。 e.期刊報告一篇，通過成績 80 分。 f. EPA可信賴專業活動信賴等級評估：	
評核項目：		評核頻率：
(EPA-3) 提供胸腹手術病人肺擴張治療照護		每六個月至少一次
(EPA-8) 使用呼吸器病人之緊急處置		每兩個月至少一次

(EPA-9) 使用呼吸器病人之轉送照護	每兩個月至少一次
(EPA-10) 使用侵襲性呼吸器病人之脫離照護	每兩個月至少一次
(EPA-11) 移除病人氣管內管之照護	每三個月至少一次
進行評核方式：臨床任務評核、OSCE教案評核、個案討論、DOPS、mini-CEX、筆試等綜合性評估。	
完訓認定：信賴等級達「Level 4 可獨立執行」	
備註：信賴等級劃分如下：	
信賴等級	內容
Level 1	學習者在旁觀察
Level 2a	教師在旁逐步共同操作。
Level 2b	教師在旁必要時協助。
Level 3a	教師事後逐項確認。
Level 3b	教師事後重點確認。
Level 3c	必要時知會教師確認。
Level 4	可獨立執行。
g.專責導師每個月一次訪談輔導，將新進人員學習情形報告組長與教學主任，必要時得以延長臨床指導時間。	
h.受訓學員對臨床教師滿意度調查：	
● 每個月教學部線上滿意度調查。	
● 每三個月新進人員對教師評核。	
● 呼吸治療暨跨領域相關課程問卷調查。	
i.受訓學員考核表：	
● 每三個月一次床邊查房病例導向討論 Case-Base-Discussion，進行 360 度評核與具體個案實證臨床應用探討。	
● 每三個月學員核心能力SIRIPPP自評及教師核心能力評核。	
j.參與其他醫療科部跨領域在職教育或討論會達 3 小時。	
※學習成效不佳之輔導機制：	
當學習成效未達標準時，由教學計畫負責人啟動輔導機制。	

三、專業課程階段

重症技能

達成目標	1、具備照護一般病人之專業能力，勝任臨床照護工作。 2、能瞭解跨領域團隊共同照護之概念，培養共同照護的模式。
訓練內容	兒童照護訓練(16 小時) a.獨力完成兒科侵襲性呼吸器設定和脫離之臨床操作。 b.獨力完成兒科非侵襲性呼吸器之臨床操作(含VN 500、AVEA、SLE 5000、SLE 6000、BiPAP、under water CPAP、Airvo2 等)。 c.瞭解早產兒RDS與呼吸治療相關處置。 d.獨力完成特殊呼吸治療技術如iNO、HFOV裝置。

	重症技能(16 小時)： a.呼吸照護評估： ●心電圖、異常檢驗值、血液動力學監測(1 小時) ●低血氧機轉與氧合監測 (TMS-86518)(1 小時) ●PV loop and optimal PEEP (TMS-86523) (1 小時) ●呼吸器波型與Reverse Triggering (TMS-148268)(1 小時) b.常見急重症加護單位之疾病與呼吸治療之應用： ●手術前後病人呼吸照護及處置(1 小時) ●VAP呼吸器相關肺炎(1 小時) ●COPD病人呼吸照護及處置(1 小時) ●ARDS病人呼吸照護及處置(1 小時) ●呼吸照護病人之營養/代謝評估(TMS-86556 營養師授課) (1 小時) ●呼吸照護病人之體液和電解質異常評估(1 小時) ●呼吸功能改善(1 小時) c.特殊呼吸治療技術： ●HFOV臨床應用(1 小時) ●iNO臨床應用(1 小時) ●Recruitment management (1 小時) ●Prone position(1 小時) ●ECMO臨床應用(1 小時) d.熟悉重症呼吸治療技術及操作： ●iNO ●HFOV-3100B ●HFOV-3100A、SLE 5000、SLE 6000、VN500 (兒科) ●Prone Position ●Recruitment Management ●Engstrom IC 操作 ●EIT操作 e.具備實證醫學與臨床應用能力
訓練時間	12 個月
訓練方式	a.依呼吸診療科呼吸治療師訓練計畫執行輪訓。 b.臨床實作學習（含小兒、重症至少各 16 小時） ●兒童照護 6-8 週。 ●兒童重症 6-8 週。 c.床邊查房CbD、個案報告討論。 d.獨立照顧成人重症病人 12-15 人，兒童與一般病房至少 15 人，依學員能力及臨床狀況由臨床指導老師彈性調整。 e.多元化教材：TMS呼吸治療專業課程必修至少 15 小時、LINE聊天機器人、SDM (氣管切開術、選擇居家與呼吸照護病房)。 f.自學：參閱標準作業程序書、工作規範、大醫雲RT電子書、TMS線上影音教學課程、教科書、PubMed、臨床指南、UpToDate等等。 g.儀器操作及各項技術之示教及回覆示教。 h.於臨床技能中心進行教案情境模擬訓練。 i.使用單位教具進行模擬訓練。

	j.參與並執行單位各組活動。 k.臨床指導老師及主管進行訪談輔導關懷座談會。 l.參與學會、公會及相關專科學會繼續教育課程。																										
評核標準 (方法)	a.專業課程：依照呼吸治療師訓練計劃專業知識課程，由專責教師進行授課與學前及學後筆試測驗，學後需通過筆試成績達 80 分以上。 b.專業技術：依呼吸診療科標準作業流程程序書，執行前測專業技術測驗達 80 分以上即不用後測，如需後測驗成績應達 80 分以上。 c.小兒HFOV呼吸器裝置與校正通過模擬測驗。 d.小兒iNO裝置與臨床處置通過模擬測驗。 e.每 3 個月運用mini-CEX直接觀察臨床知識、技能和態度等專業能力，並予以回饋。 f.個案報告一次，通過成績 80 分。 g.文獻實證專題報告一次，通過成績 80 分。 h. EPA可信賴專業活動信賴等級評估： <table><tr><td>評核項目：</td><td>評核頻率：</td></tr><tr><td>(EPA-7) 呼吸窘迫病人之處置</td><td>每兩個月至少一次</td></tr><tr><td colspan="2">進行評核方式：臨床任務評核、OSCE教案評核、個案討論、DOPS、mini-CEX、筆試等綜合性評估。</td></tr><tr><td colspan="2">完訓認定：信賴等級達「Level 4 可獨立執行」</td></tr><tr><td colspan="2">備註：信賴等級劃分如下：</td></tr><tr><td>信賴等級</td><td>內容</td></tr><tr><td>Level 1</td><td>學習者在旁觀察</td></tr><tr><td>Level 2a</td><td>教師在旁逐步共同操作。</td></tr><tr><td>Level 2b</td><td>教師在旁必要時協助。</td></tr><tr><td>Level 3a</td><td>教師事後逐項確認。</td></tr><tr><td>Level 3b</td><td>教師事後重點確認。</td></tr><tr><td>Level 3c</td><td>必要時知會教師確認。</td></tr><tr><td>Level 4</td><td>可獨立執行。</td></tr></table>	評核項目：	評核頻率：	(EPA-7) 呼吸窘迫病人之處置	每兩個月至少一次	進行評核方式：臨床任務評核、OSCE教案評核、個案討論、DOPS、mini-CEX、筆試等綜合性評估。		完訓認定：信賴等級達「Level 4 可獨立執行」		備註：信賴等級劃分如下：		信賴等級	內容	Level 1	學習者在旁觀察	Level 2a	教師在旁逐步共同操作。	Level 2b	教師在旁必要時協助。	Level 3a	教師事後逐項確認。	Level 3b	教師事後重點確認。	Level 3c	必要時知會教師確認。	Level 4	可獨立執行。
評核項目：	評核頻率：																										
(EPA-7) 呼吸窘迫病人之處置	每兩個月至少一次																										
進行評核方式：臨床任務評核、OSCE教案評核、個案討論、DOPS、mini-CEX、筆試等綜合性評估。																											
完訓認定：信賴等級達「Level 4 可獨立執行」																											
備註：信賴等級劃分如下：																											
信賴等級	內容																										
Level 1	學習者在旁觀察																										
Level 2a	教師在旁逐步共同操作。																										
Level 2b	教師在旁必要時協助。																										
Level 3a	教師事後逐項確認。																										
Level 3b	教師事後重點確認。																										
Level 3c	必要時知會教師確認。																										
Level 4	可獨立執行。																										
	i.專責導師每個月一次訪談輔導，將新進人員學習情形報告組長及教學主任必要時得以延長臨床指導時間。 j.受訓學員對臨床教師滿意度調查： ● 每個月教學部線上滿意度調查。 ● 每三個月呼吸診療科新進人員對教師評核。 ● 呼吸治療暨跨領域相關課程問卷調查。 k.受訓學員考核表： ● 每三個月一次床邊查房病例導向討論 Case-Base-Discussion，進行 360 度評核與具體個案實證臨床應用探討。 ● 每三個月學員核心能力SIRIPPP自評及教師核心能力評核。 l.參與其他醫療科部在職教育或討論會達 5 小時。																										

	※學習成效不佳之輔導機制: 當學習成效未達標準時，由教學計畫負責人啟動輔導機制。
--	--

四、跨領域團隊合作照護

訓練內容	跨領域團隊合作照護訓練
訓練時間	二年 每三個月一次，平均每次參與 1 小時，兩年合計共訓練 8 小時
訓練方式	a.每日各單位主治醫師床邊查房教學。 參加人員：主治醫師、醫師、藥師、呼吸治療師、專科護理師。 b.每週呼吸診療科主任內外科加護病房、呼吸照護中心 RCC 床邊查房病例導向討論 Case-Base-Discussion。 參加人員：主任、醫師、呼吸治療師、專科護理師與護理人員。 c.每週呼吸診療科聯合個案討論會或期刊討論會。 參加人員：主治醫師、醫師與呼吸治療師。 d.每三個月舉辦肺復原個案討論會。 參加人員：主治醫師、醫師、呼吸治療師、物理治療師。 e.每三個月或不定期舉辦跨領域專家專題演講或個案討論會。 參加人員：主治醫師、醫師、呼吸治療師、其他醫事人員。 f.每三個月或不定期其他科部上課課程或個案討論會。 參加人員：主治醫師、醫師、呼吸治療師、其他醫事人員。 g.不定期舉辦情境模擬教案訓練。 參加人員：主治醫師、醫師、呼吸治療師、其他醫事人員。
評核標準 (方法)	每三個月一次，床邊查房病例導向討論 CbD 通過成績 80 分。 每三個月跨領域討論活動紀錄。 呼吸治療相關課程滿意度問卷調查。

五、其他訓練課程

訓練內容	聯合訓練計畫： a.本院可獨立完成二年期呼吸治療師訓練計畫項目，不需外訓。 b.可接受代訓其他醫院學員，其訓練項目、訓練時間、訓練方式配合申請醫院提出之聯合訓練計畫進行訓練。 c.聯合訓練機制參照以上訓練課程。
訓練時間	6 週 (成人重症 2 週，小兒 4 週) 可配合申請醫院需求時間
訓練方式	以學習者為中心，參照本院訓練計畫予以安排並配合學員實際需求及業務狀況調整；安排臨床教師定期討論。
評核標準 (方法)	依據以上之計畫訂定之評核方式，定期實施教與學的雙向回饋調查及考核。

伍、輔導補強機制

- 一、學員學習成效不佳者必須提供輔導措施，係指學員在訓練課程中測驗分數及技術評量成績不良、學習怠惰或是學習進度緩慢等學習成效不良現象，以及壓力適應不佳

等足以影響學習效果者。針對學習成效不佳之受訓人員，先由訓練計畫課程負責人提供個別化的輔導，了解受訓人員是因課程階段性學習問題、學習成效不良及適應不佳、臨床病人安全照護等問題，針對問題尋求解決方案，例如：增加課程安排、多元化教材、擬真教案訓練、增加床邊查房病例導向討論次數、科內 TMS 影音教學課程學習、參與跨領域課程與病例研討會、必要時延長階段性訓練時間。並於 CCC 臨床能力委員會以多元化方式定期評估學習成效，將依據評估結果，適時啟動輔導補強機制，實際回饋評估結果協助學員提升臨床能力，提供適切支持並檢討訓練課程內容。對於學習成果不佳之受訓人員至少完成一次補強訓練，並將紀錄留存。於 CCC 臨床能力委員會與教師會議並討論補救辦法，必要時報告呼吸診療科主任，並陳報教學部及院方。

- 二、受訓人員若因故無法如期完成訓練課程時，另訂有檢討補救機制，「以學習者為中心」安排受訓人員完成原有之訓練課程內容。將利用如：彈性安排課餘學習與數位學習平台等較為多元彈性的方式安排訓練進度；並視受訓人員能力、經驗及需要調整進度，如視受訓人員個人之學習狀況，必要時延長訓練時間，給予較充裕的時間完成訓練。

陸、雙向回饋機制

俾使新進呼吸治療師於學習過程中有適當之問題反應機會，並使臨床指導教師能瞭解問題並針對問題予以適當回覆，本科明訂相關機制以提供學員與臨床指導教師雙向回饋之管道。

一、訓練中即時回饋：

新進呼吸治療師於臨床學習過程中如遇問題，可立即向當站臨床指導教師反應，由指導教師給予即時回覆，當下無法立即解決之問題或狀況，指導教師回報教學主任或組長，於主管會議或教學會議中提出討論。

二、導師生活輔導訪談：

每月一次由專責導師與新進呼吸治療師進行訪談，內容包含壓力量表瞭解學員在臨床工作、生活調適與學習情況、學員的工作反思與反饋，並且藉由實證醫學與學員進行臨床議題的討論以及提升臨床專業度。

三、學習評估表單之雙向溝通：

在每個訓練階段完成後，臨床教師必須結合其他意見，就學員的強項和需改進部分提供回饋。新進呼吸治療師可以針對訓練內容提出意見並記錄於相關文件中，例如：標準技術作業流程技術考、EPA 可信賴專業活動、迷你臨床演練與評估表 (Mini-CEX)、床邊查房病例導向討論 (CbD)，輔導訪談紀錄表等。

四、問卷調查：

- (一)科部每週課程滿意度調查：本部以線上方式調查新進呼吸治療師之學習經驗與建議，教學組彙整回饋意見，並於雙向溝通會議討論，藉此改善訓練模式。
- (二)教學部網路平台滿意度調查：針對臨床指導呼吸治療師進行教學技能、教材準備、專業知識之評分與建議。
- (三)科部教師檢核表：主管每兩季進行一次，並有簽收機制，使臨床指導教師可以實

際了解教學回饋內容。

- (四)個人化教學滿意度成績之回饋：新進醫事人員對臨床教師之教學滿意度評分結果，每位臨床教師可於台大醫院臨床教育 e-Portfolio 系統即時查詢學生及學員之回饋內容，以利臨床教師反思與改進教學方式。

五、教學暨科務會議：

- (一)每三個月由科主任及計畫主持人召開，導師定期與新進人員進行雙向溝通，了解新進呼吸治療師臨床工作上所遇到的困難及相關學習問題，導師於教學會議時提出討論。臨床教師每三個月針對 PGY 學員日常工作表現進行評核，經會議後調整教學方法與相關之補強輔導措施。
- (二)每年計畫主持人和導師進行計畫內容檢討並修訂，並參考學員回饋意見及學員實際學習狀況。

六、CCC 臨床能力委員會：

- (一) 新進人員第三個月開第一次會議，之後每半年及必要時開會。
- (二) CCC 會議宗旨為以集體智慧建立形成性評量，以公平、客觀的方式綜合評估學員的臨床表現以及專業能力，並給予階段性的學習回饋以促進專業成長。